VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

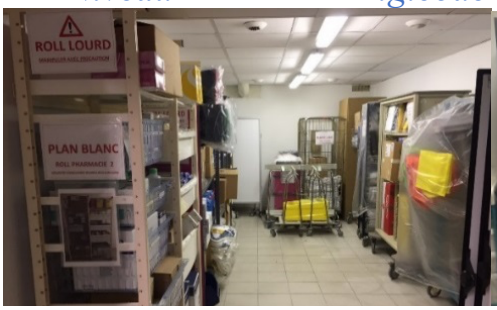
MISSION DE L'EXTERNE - ✆ N° TEL

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Récupérer la clé de l'ascenseur dans la mallette Plan Blanc
- ☐ Accompagné d'**1 ASH et des externes,** aller chercher **:**
  - **Les Paper Board dans le local NRBC** situé à côté du local poubelle du SAU.
  - Les 3 rolls « Plan Blanc » de pharmacie + le roll lingerie + le roll signalétique + le chariot de soins, prêts et stockés dans la réserve SAU *:*

Niveau -1 *Digicode : **Code de la porte***

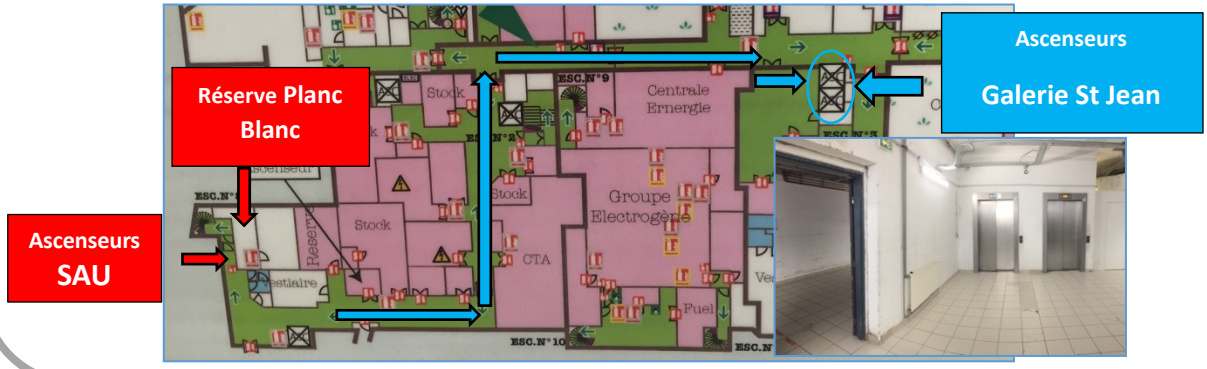




2

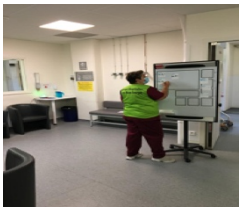
☐ **Monter les rolls en empruntant l'ascenseur des urgences**

En cas de panne de l'ascenseur du SAU : emprunter les ascenseurs de la galerie St-Jean, porte 2 pour monter les rolls (flèches bleues sur le schéma ci-dessous).



3

- ☐ Installer les **rolls Plan Blanc** dans le couloir contre le mur de la zone F
- ☐ Déposer les **boites de garrots** (à l'étage supérieur du roll n°3) sur le chariot de soins de la SAUV.
- ☐ Installer les **paper-boards** :
  - 1 en zone de tri
  - 1 devant le box 1
  - 1 dans la zone UR
  - 1 en zone UA
  - 1 en zone transitoire.




- ☐ Installer le **roll signalétique** à côté de l'entrée du poste de soins

Lorsque l'installation est terminée :

☐ Se mettre à disposition du sénior à l'accueil pour accompagner les patients en zone UR, UA ou en salle d'attente impliqués

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Missions De l'interne Plan AMaVi

CHASUBLE JAUNE

AVANT L'ARRIVEE DES RENFORTS

□ Transmettre ses patients en cours à l'interne de la zone de transition et se positionner dans le poste de soin de Zone 2 à proximité du sénior « Plan blanc et de l'IDE « Plan blanc »

□ Avertir les manip radio du déclenchement du plan blanc en appelant
de jour : 6034 / de nuit : 7644
□ Récupérer la liste du personnel médical à contacter

□ Appeler des séniors en renfort jusqu'à l'obtention de l'effectif nécessaire selon le tableau ci-joint.

Sénior 1 …….
Sénior 2 …….
Sénior 3 …….
Senior 4 …….
Sénior 5……..

□ Appeler des internes en renfort jusqu'à l'obtention de l'effectif nécessaire selon le tableau ci-joint.

Interne 1 …….
Interne 2 …….
Interne 3 …….
Interne 4 …….
Interne 5 ……..

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

□ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée

□ Se positionner dans une zone de soins selon l'affectation prévue par le sénior « Plan Blanc »

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS DU MEDECIN PLAN BLANC - ✆ N° TEL

CHASUBLE BLEU

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

1

- ☐ Prévenir l'équipe soignante en composant le **N° TEL**
- ☐ Répartir l'équipe présente sur place
- ☐ Désigner un IDE « Plan Blanc » (expérimenté) et lui remettre sa fiche réflexe
- ☐ Afficher le plan des urgences sur tableau velleda le long du mur de la SAUV
- ☐ Appeler :
  - ☐ Chef de service (**N° TEL**) ; Chef de service adjoint (**N° TEL**) ;
  - ☐ Le directeur ou l'administrateur de garde (passer par le standard : « **N° TEL** »)
  - ☐ Le réanimateur de garde (**N° TEL**)
  - ☐ Jour : le responsable de la gestion des lits (**N° TEL**)
  - ☐ Week-end et jours fériés : le cadre de garde (**N° TEL**)
  - ☐ Nuit : les cadres de nuit (**N° TEL**)
- ☐ Libérer la SAUV
- ☐ Pour la zone des urgences relatives (UR), libérer par ordre de priorité les zones.
- ☐ Pour la zone Transitoire :
  - Un côté pour patients à hospitaliser
  - Un côté pour les patients moribonds
- ☐ Pour les patients hors plan blanc, autres boxes
- ☐ Désigner un interne pour appeler les séniors et internes jusqu'à obtenir l'effectif médical nécessaire selon le tableau ci-joint (voir liste jointe)
- ☐ Transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- ☐ Prendre le rôle de MÉDECIN TRIEUR dans le SAS pompier en attendant les renforts

APRES L'ARRIVEE DES RENFORTS

2

- ☐ Désigner un médecin trieur : ……..
- ☐ Répartir les effectifs médicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
- ☐ Rester le médecin « leader » du plan blanc (ne fait pas de soin)
- ☐ Suivre le décompte précis des victimes arrivées au SAU
- ☐ Rôle administratif en lien avec la cellule de crise, les cadres, le gestionnaire de lits
- ☐ Aider à désengorger les zones de soins
- ☐ Rester avec l'IDE Plan Blanc et avec le chirurgien
- ☐ Assurer la coordination des différentes zones
- ☐ Adapter les postes de chacun en fonction du flux des victimes
- ☐ Renforts possibles :
- ☐ médecin et IDE des lits portes (renfort UA ou selon le flux)
- ☐ ASH lits portes (coursier pour bilan biologique à apporter au labo)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Missions du Médecin « TRIEUR » N° TEL

Premier médecin renfort expérimenté arrivé au SAU

CHASUBLE JAUNE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

1. Contrôle du personnel en place au tri à l'accueil :
   - ☐ AS identito-vigilance : ……
   - ☐ Brancardier : …… (Externe si brancardier non encore disponible)
   - ☐ Agent d'accueil (N° TEL) : …….
   - ☐ IOA (N° TEL): ……

   Médecin trieur et AS identitovigilance restent en permanence dans le SAS pompiers

2. Vérifier le matériel en place
   - ☐ Tableau Velléda en place + feutres + boites avec dossiers patients et fiches de tri

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2

3. Tri et décompte des victimes
   - ☐ Noter sur la fiche « Tri médical » plan blanc le tri de la victime
   - ☐ Communiquer le tri à l'AS identitovigilance
   - ☐ Noter sur le tableau le nombre de victimes dès leur arrivée et leur tri : ex UA : 1, 2, 3 …UR : 1, 2,3

UA (urgence absolue) SAUV	- Victime en danger de mort immédiate - Geste chirurgical de sauvetage - Instabilité, décompensation d'une fonction vitale - Lésion avec impact fonctionnel évident (visage, œil, main)
UR (urgence relative) Zone UR	- Pas d'engagement du pronostic vital à court terme - Traumatisme susceptible de s'aggraver (thorax, abdomen, crâne) - Traitement chirurgical pouvant être différé - Blessures légères
IMP (impliqué) Attente valide	- Pas de prise en charge organique urgente - Nécessité d'écoute ou d'information
UD (urgence dépassée) Zone transitoire	- Lésions gravissimes avec peu de chance de survie - Patient décédé

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Rappels : Triage selon la Société Française de Médecine de Catastrophe.

UA	**Catégorisation**	**Type de lésions**
EU	**Extrêmes urgences**	Victimes en danger de mort immédiate : -Insuffisance cardiocirculatoire (polytraumatisme, syndrome d'écrasement…) -Hémorragies graves incontrôlables (abdominales, vasculaires, non garrotables…) -Asphyxies (blessés thorax, cervico-maxillo-faciaux, gazés graves) -Traumatisés crâniens avec signes de localisation -Brulures > 50%
U1	**Première Urgence** Délai chirurgical ≤6H	Victimes graves menacées par la décompensation de fonctions vitales (choc, détresse respiratoire, neurologique) ou par un sepsis : -Blessés thoracique et gazés non asphyxiques ; -Plaies vasculaires garrotables ; -TC comateux sans signe de localisation ; -Fractures ouvertes et plaies ostéoarticulaires ; -syndrome de compression ; -brulures profondes entre 15 et 50% -Hypothermie <32°C.
UF	Urgences fonctionnelles (UF)	Lésions caractérisées par leurs topographies (œil, visage, main), l'absence de mise en jeu du pronostic vital et la possibilité d'un impact fonctionnel et esthétique : -Plaie pénétrante de l'œil ; -Traumatisme délabrant des extrémités ; -Brulures circulaires des membres, mains ; -Traumatismes maxillofaciaux.

UR	**Catégorisation**	**Type de lésions**
UP	Urgences potentielles	Lésions susceptibles de s'aggraver : -Traumatismes cranio-encéphaliques ; -Traumatismes abdominaux ou thoraciques ; -Suspicion de blast pulmonaire ou abdominal ; -Lésions par ensevelissement.
U2	Deuxième urgence Délai chirurgical≤18H	Victimes peu graves dont le traitement chirurgical des lésions peut être effectué dans les 12 à 24H : -fractures de la diaphyses fermées ; -Plaies des parties molles (sauf fesses et périnée) -TC Conscients ; -Brulures < 15% -Intoxications par inhalation avec disparition de la symptomatologie neurologique et respiratoire.
U3	Troisième urgence Délai chirurgical ≤36H	Blessures légères caractérisées par l'absence d'évolutivité, la possibilité d'évacuation dans un délai de > 18Het sans recours à une médicalisation de transport -Traumatismes fermés (entorses, contusions) ; -Petites plaies contuses ; -brulures superficielles < 15%
UP	Urgences dépassées (mesures d'accompagnement)	Lésons gravissimes ne pouvant pas être traitées immédiatement et n'ayant que peu de chance de survie

IMP	Impliqué	Tous les patients ne nécessitant pas une prise en charge « organique » médicale urgente mais nécessitant une écoute ou une information qui seront délivré par l'équipe de psychiatrie

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSION DU MEDECIN IMPLIQUE - N° TEL

CHASUBLE VERTE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

□ Inscrire son nom sur le plan de zone
□ Prendre sa chasuble : **Imp (vert)**
□ Prendre son DECT :
IMP : **N° TEL**
□ Se positionner dans sa zone

2

Vérifier le personnel en place dans la zone :
Séniors ……...
Internes ……..
IDE …….
Aide-soignant …….
Autres …….

3

□ Se positionner dans une zone de soins selon l'affectation prévue et préparer le matériel nécessaire
□ Tableau Velléda pour le décompte des victimes
□ registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

□ Examen et PEC du patient
□ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
□ examens complémentaires papiers
□ S'assurer que le dossier reste avec le patient
□ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
□ Décompte précis des victimes pour les transmettre au médecin Plan Blanc

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE

(Sauf décision du médecin Plan Blanc)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSION DU MEDECIN UR

CHASUBLE ORANGE 

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- □ Inscrire son nom sur le plan
- □ Prendre sa chasuble : **UR (ORANGE)**
- □ prendre une pochette stylos et numéros utiles
- □ Prendre son DECT : **N° TEL**
- □ transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- □ Se positionner dans sa zone

2

Contrôle du personnel en place dans la zone :

Sénior ……
Interne ……
IDE ……
Aide-soignant ……
Autre ……..

3

Se positionner dans sa zone et préparer le matériel nécessaire :

Tableau Velléda pour le décompte des victimes
Registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

- □ Décompte précis des victimes pour médecin Plan Blanc
- □ Examen et PEC du patient
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ Examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que le dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
- □ Appeler le radiologue si TDM urgent N° TEL
- □ Coursier pour apporter les bilans au laboratoire (N° TEL)

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS MEDECIN UA - ✆ N° TEL

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- □ Inscrire son nom sur le plan
- □ Prendre sa chasuble : **UA (ROUGE)**
- □ prendre une pochette stylos et numéros utiles
- □ Prendre son DECT : **N° TEL**
- □ transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- □ Se positionner dans sa zone

2

Contrôle du personnel en place dans la zone :

Sénior …….
Interne ……
IDE …….
Aide-soignant …….
Autre ……..

3

Se positionner dans sa zone et préparer le matériel nécessaire :

Tableau Velléda pour le décompte des victimes
Registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

- □ Décompte précis des victimes pour médecin Plan Blanc
- □ Examen et PEC du patient
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ Examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que le dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
- □ Appeler le radiologue si TDM urgent N° TEL
- □ Coursier pour apporter les bilans au laboratoire (N° TEL)

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS DU MEDECIN ZONE TRANSITOIRE - N° TEL

CHASUBLE GRISE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- □ Inscrire son nom sur le plan de zone
- □ Mettre sa chasuble grise
- □ Prendre son DECT : N° TEL
- □ Se positionner dans sa zone

2
- □ Vérifier le personnel en place dans la zone :
  - Séniors …….
  - Internes …….
  - IDE …….
  - Aide-soignant …….
  - Autres …….

3
- □ Prendre les transmissions des patients déjà aux urgences
- □ Se positionner dans sa zone.
- □ Organiser la zone :
  - Un côté pour les patients à hospitaliser
  - Un côté pour les patients moribonds
- □ Tableau Velléda pour décompte des victimes
- □ Prendre en charge les patients hors plan blanc une fois la zone transitoire vidée

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

4
- □ Suivre la PEC des patients transmis
- □ faire monter dans les étages les patients transmis hors plan blanc (en lien avec le gestionnaire de lits)
- □ Suivre la PEC des victimes en attente de leur transfert
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient) Le dossier reste avec le patient
- □ Décompte précis des victimes et leur orientation pour médecin Plan Blanc

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS MEDECIN LP - N° TEL

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- □ Transmettre ses patients au médecin LP 2
- □ Descendre en binôme avec l'IDE LP1 pour renforcer l'équipe UA
- □ Inscrire son nom sur le plan de zone
- □ Prendre sa chasuble : **UA (rouge)**
- □ Prendre son DECT : **N° TEL**
- □ Se positionner dans sa zone

2

Se positionner dans une zone de soins selon l'affectation prévue et vérifier le matériel nécessaire :

Tableau Velléda pour le décompte des victimes
Registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

3

- □ Examen et PEC des patients
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée